BÖLÜM 10

Karma Yöntemler

Sayıların gücü ile hasta sesinin derinliğini tek çalışmada birleştirmek

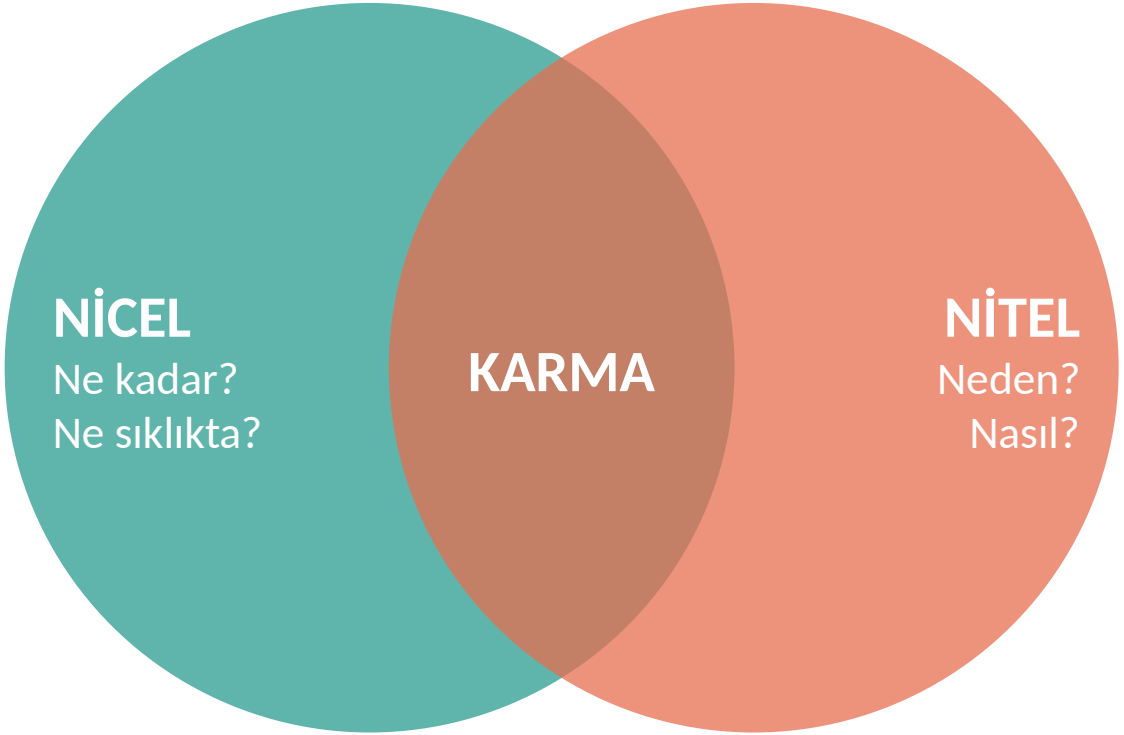


TANIM

Karma yöntem nedir?

Aynı araştırmada **nicel** ve **nitel** verilerin toplanması, analiz edilmesi ve **bütünleştirilmesidir.**

- Tek başına ne sayılar ne de sözcükler sağlık sorunlarının tamamını açıklayabilir.
- Amaç: bir yöntemin zayıf yönünü diğerinin güçlü yönüyle dengelemek.
- Sağlık hizmetleri, hemşirelik ve halk sağlığı araştırmalarında giderek yaygınlaşıyor.



Kaynak: Creswell & Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research

GEREKÇELER

Neden karma yöntem kullanırız?

Üçgenleme

Farklı yöntemlerle aynı sonuca ulaşıp bulguyu doğrulamak

Tamamlayıcılık

Bir olgunun farklı yönlerini birlikte görmek

Açıklama

Beklenmedik bir istatistiksel sonucun nedenini anlamak

Geliştirme

Nitel bulgulardan ölçek, anket veya müdahale tasarlamak

Genişletme

Araştırmanın kapsamını ve genellenebilirliğini artırmak

Hasta sesi

Klinik sonuçlara hastanın deneyimini ve önceliklerini eklemek

KARŞILAŞTIRMA

Nicel ve nitel yaklaşım yan yana

Özellik	Nicel	Nitel
Temel soru	Ne kadar? Ne sıklıkta? İlişki var mı?	Neden? Nasıl? Nasıl deneyimleniyor?
Veri	Ölçümler, anketler, laboratuvar değerleri	Görüşme, odak grup, gözlem notları
Örneklem	Büyük, olasılıklı, temsil edici	Küçük, amaçlı, bilgi açısından zengin
Analiz	İstatistiksel testler, modeller	Tematik / içerik analizi
Tıbbi örnek	Tedavi sonrası sistolik KB 12 mmHg düştü	Hasta: “İlaç beni yoruyor, bazen atlıyorum”

Karma yöntem bu iki sütunu rakip değil, ortak olarak görür.

Dört temel karma yöntem deseni

Yakınsayan paralel
İki veri eş zamanlı, sonra karşılaştırılır



Açıklayıcı sıralı
Sayılar önce, nedenler sonra



Keşfedici sıralı
Önce keşfet, sonra ölç



Gömülü (iç içe)
Ana çalışmanın içine ikincil bir bileşen



Gösterim: BÜYÜK HARF = öncelikli yöntem, küçük harf = destekleyici yöntem; ok (→) = sıra

ÖRNEK 1 · AÇIKLAYICI SIRALI DESEN

Tip 2 diyabette ilaç uyumu neden düşük?

1. NİCEL aşama

- 400 hastaya ilaç uyum ölçeği + HbA1c ölçümü
- Her 3 hastadan 1'inde düşük uyum
- Düşük uyum → daha yüksek HbA1c

2. nitel aşama

- Uyumu düşük 20 hastayla derinlemesine görüşme
- Temalar: yan etki korkusu, ilaç maliyeti, "kendimi iyi hissediyorum" inancı

3. Bütünleştirme

- Sayılar sorunun büyüklüğünü, görüşmeler nedenini gösterdi
- Sonuç: hedefe yönelik hasta eğitim programı

Neden karma? Anket "ne kadar" sorusunu yanıtladı; "neden" sorusunu yalnızca hastalarla konuşarak öğrenebildik.

Eğitim amaçlı örnek senaryo; sayılar temsilidir.

ÖRNEK 2 · KEŞFEDİCİ SIRALI DESEN

Yoğun bakım hemşirelerinde tükenmişlik ölçeği

1. NİTEL keşif

- Hemşirelerle 4 odak grup görüşmesi
- Temalar: gece nöbeti, hasta kaybı, ekipman eksikliği

2. Araç geliştirme

- Temalardan maddeler yazıldı
- Uzman görüşü ve pilot uygulama ile ölçek taslağı

3. NİCEL test

- 300 hemşirede uygulama
- Faktör analizi ile geçerlik
- Cronbach alfa ile güvenirlik

Neden karma? Hazır ölçek yoksa maddeleri hemşirelerin kendi sözlerinden türetmek, ölçeği bu gruba gerçekten uygun kılar.

Eğitim amaçlı örnek senaryo.

ÖRNEK 3 · YAKINSAYAN PARALEL DESEN

Aşı tereddüdü: birleşik gösterim tablosu

Tema	Nicel bulgu (anket, n = 1000)	Nitel bulgu (görüşme, n = 25)	Sonuç
Güvenlik endişesi	Katılımcıların yarısına yakını yan etkiden korkuyor	“Çok hızlı geliştirildi, uzun vadede ne olacak?”	**Doğruluyor**
Bilgi kaynağı	Sosyal medya kullanımı arttıkça tereddüt artıyor	“Doktordan çok mesaj gruplarına güveniyorum”	**Genişletiyor**
Hekime güven	Hekime güven puanı yüksek (5 üzerinden 4)	“Doktoruma güvenirim ama sağlık sistemine güvenmem”	**Çelişiyor**



Çelişki bir hata değil, bir bulgudur: kişiye güven ile kuruma güven ayrı ele alınmalı.

Eğitim amaçlı örnek senaryo; sayılar temsilidir.

ÖRNEK 4 · GÖMÜLÜ DESEN

Diz osteoartritinde ev egzersiz programı RKÇ'si



NİCEL ana çalışma: RKÇ

- 120 hasta: egzersiz ve kontrol grubu
- 12. haftada ağrı (VAS) ve fonksiyon (WOMAC)

nitel bileşen (gömülü)

- Programı sürdüren ve bırakan 15 hastayla görüşme
- Engeller: ağrı artışı korkusu, zaman yokluğu
- Kolaylaştırıcı: telefonla hatırlatma

Ne kazandık?

- RKÇ "Etkili mi?" sorusunu yanıtlar.
- Nitel bileşen "Neden işe yaradı ya da yaramadı?" sorusunu yanıtlar.
- Nitel veri çalışmadan önce, sırasında veya sonrasında toplanabilir.
- Sonuçların klinik uygulamaya aktarımı kolaylaşır.

Bütünleştirme: karma yöntemin kalbi



Bağlama
Bir aşamanın örneklemi diğer aşamadan seçilir (ör. uyumu düşük hastalar)



İnşa etme
Bir aşamanın bulguları diğerinin aracını oluşturur (ör. ölçek maddeleri)



Birleştirme
İki veri seti analizde yan yana konur (ör. birleşik gösterim tablosu)



Gömme
Bir veri, diğerinin çerçevesi içinde toplanır (ör. RKÇ içinde görüşme)

> **Bütünleştirme yoksa elinizde karma yöntem değil, aynı konuda yapılmış iki ayrı çalışma vardır.**
>
> *Fetters, Curry & Creswell, Health Services Research, 2013*

DEĞERLENDİRME

Güçlü yönler ve sınırlılıklar



Güçlü yönler

- Daha kapsamlı ve inandırıcı kanıt
- İstatistiksel sonuca anlam ve bağlam katar
- Hasta merkezli müdahale tasarımına uygun
- Bir yöntemin zayıflığını diğeri dengeler



Sınırlılıklar

- Daha fazla zaman, bütçe ve emek gerektirir
- Ekipte her iki yöntemde de uzmanlık gerekir
- Bütünleştirme ve raporlama zordur
- Çelişen bulguları yorumlamak beceri ister

Ne zaman seçmeli? Araştırma sorusu tek bir yöntemle tam yanıtlanamıyorsa.

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

1	**Tanım**	Karma yöntem = nicel + nitel + bütünleştirme
2	**Amaç**	“Ne kadar?” ve “Neden?” sorularını birlikte yanıtlamak
3	**Desenler**	Yakınsayan paralel, açıklayıcı sıralı, keşfedici sıralı, gömülü
4	**Tıpta**	İlaç uyumu, ölçek geliştirme, aşı tereddüdü, RKÇ süreç değerlendirmesi
5	**Kilit nokta**	Bütünleştirme yoksa karma yöntem de yoktur

Kaynaklar: Creswell & Plano Clark (2018), Designing and Conducting Mixed Methods Research; Fetters, Curry & Creswell (2013), Health Services Research 48(6).